乡村健康 · 农业劳动 · 医疗可及性

农村农业劳动者就医摩擦框架

劳动条件 → 五类就医摩擦 → 延迟就医

原版五类摩擦结构 · 项目发展稿

劳动条件先产生摩擦，随后导致延迟就医

劳动条件

农事日历
长时间劳动
时效性强的农活
家庭劳动力结构

1 **劳动时间摩擦**
农忙时无法停下劳动

2 **替工摩擦**
没有可靠的人接手农活

3 **时间与收入摩擦**
就医半天，损失农活或工资收入

4 **交通摩擦**
距离、公交时间、换乘

5 **数字摩擦**
挂号、选科室、依赖他人

延迟就医

推迟预约
身体不适仍继续劳动
直到功能下降才求医

该框架解释了：医疗服务即使存在，也可能仍然难以真正使用。

每类摩擦都有不同的证据信号和作用机制

这张矩阵把“数据说明了什么”与“访谈解释了为什么”分开。

摩擦	量化信号	作用机制	证据强度	框架用途
劳动时间	75.4%经常或有时缺少时间；日劳动超过6小时者更常延迟就医	农活需要连续完成，并且受到农时限制	较强	解释时间贫困
替工	无替工者延迟就医85.7%；有一定替工者为74.5%	替工者需要懂农活，并能够承担责任	较强	解释无法离开农活
时间与收入	74.1%面对半天就医会犹豫；收入压力普遍	成本还包括错过采收、订单、工资和家庭产出	混合	解释机会成本
交通	27.2%报告交通障碍；实测公交约30-90分钟	距离通过换乘和不确定的返程时间转化为摩擦	中等	解释物理可及性
数字	55.8%挂号能力较弱；60岁以上群体明显更高	困难集中在选医院和科室、认证、医保及结果查询	很强	解释导航依赖

证据强度用于确定设计优先级，并不意味着该框架已经成为经验证的临床量表。

旅程1：劳动与替工障碍相互叠加

葡萄种植者 · 采收期 · 工作时间长 · 反复腰痛

触发

关键农忙阶段出现疼痛

采收无法简单顺延；今天没做的农活会立即积压。

摩擦链

无人能够可靠替工半天

家人也许能短暂帮忙，但无法完整接手农活。

结果

一直劳动，直到功能下降

延迟就医，直到疼痛影响睡眠、行走或搬抬。

最适合的应对方案　农忙前义诊 + 提前安排替工 + 肌肉骨骼危险信号提示

旅程2：数字与交通障碍把一次就医变成一连串难题

年长农业劳动者 · 膝痛 · 依赖家人完成医院导航

触发

需要村卫生室以外的诊疗

下一步需要选择医院、科室和预约时间。

摩擦链

家人不在、挂号不清楚、路程较长

数字操作与30-90分钟的公交行程相互叠加。

结果

推迟就医，或只能接受不完整帮助

医疗服务虽然存在，但无法独立完成整个就医路径。

最适合的应对方案　固定就医导航联系人 + 线下挂号协助 + 交通路线卡

旅程3：机会成本仍可能成为主要障碍

按产量计酬的中年农业劳动者 · 会使用智能手机 · 有交通工具

触发

工作日出现尚可忍受的症状

能够自己挂号和前往医院，传统可及性指标看起来良好。

摩擦链

停下劳动会立即损失收入

有人替工也无法补回个人工资或农业产出。

结果

会用数字工具，仍然延迟就医

真正起决定作用的是半天就医带来的经济成本。

最适合的应对方案 晚间服务 + 可预期的短时就诊 + 减少重复往返

框架把问题诊断转化为干预设计

五类摩擦需要不同方案；一次健康讲座无法解决全部问题。

摩擦	诊断问题	主要应对	实施设计	评估指标
劳动时间	劳动者能否离开农活2-4小时?	提供与农时兼容的服务	村内服务、晚间服务或农忙前服务	离开农活的时间
替工	谁能够可靠接手农活?	提前安排替工	就诊前制定家庭或邻里替工计划	有替工保障的就诊完成率
时间与收入	半天就医会失去什么?	降低机会成本	缩短预约，一次完成多项检查	节省的工时与往返次数
交通	需要多久、换乘几次?	将服务带近或简化出行	路线卡、转诊与交通支持	门到门总时间
数字	没人帮助时卡在哪一步?	提供持续的导航支持	线下挂号和固定协助人	独立或协助完成率

目标不是提供更多信息，而是减少从健康需求到真正可用医疗服务之间的摩擦。